

01 · 진단 리포트

구조화 요약 + 6축 점수 + 강점·리스크·검증 가정

표현 원칙(고정): 본 서비스는 진단·치료·처방·응급대응을 수행하지 않는 **생활 관찰·상담 참고 도구**입니다. X/Y/Z 음성·언어 지표는 임상적으로 확정된 지표가 아니라 **"검증 설계를 동반한 참고 지표(미검증 가정)"**로만 기술합니다. · "6축"은 제품 알고리즘의 3축이 아니라 **사업 진단 6개 축**으로 정의했으며, 점수는 외부 검증값이 아닌 **내부 자기진단(0~100)**입니다.

1. 구조화 요약

한 줄 정의	고령 부모를 둔 보호자가 매일 직접 확인하지 않아도, AI 안부전화 대화에서 평소와 다른 변화 를 먼저 관찰할 수 있게 하는 서비스
핵심 메커니즘	정기 AI 전화/통화 시뮬레이션 → 자연 대화 수집 → 복약·식사·일정인지·사건기억·발화특성 구조화 → 개인 기준선 대비 종단 변화 관찰 → 보호자 알림·의료진 참고 리포트
1차 고객(지불자)	40~60대 보호자 자녀 (특히 부모와 떨어져 거주)
최종 사용자	경도인지장애 위험군~초기 단계 고령 부모
2차 고객(B2B)	신경과·정신건강의학과 의원, 치매안심센터, 요양기관
기술 현황	알고리즘 v2 (이중 트랙: ① 로버스트 z-score+EWMA로 급성 이탈, ② Mann-Kendall 추세+Theil-Sen 기울기+CUSUM으로 점진적 변화, 보조 지표 Mahalanobis D ²). MVP는 통화 시뮬레이션 기반 전체 데이터 흐름 검증 단계
포지셔닝	비진단 생활관찰·상담참고 (의료기기 규제 부담 회피 + 의료진 연계 가능)

2. 6축 점수 (내부 자기진단)

#	축	점수	근거 (사실 / 한계)
1	문제 정의	80	초고령사회 진입·치매/돌봄 부담은 실재. 보호자 페인(원거리·비정형 확인)도 명확. 한계: "AI 전화로 이 문제를 푼다"는 시장 인식은 아직 약함
2	솔루션 적합성	70	이중 트랙 알고리즘 설계 정교, 비진단 포지셔닝 합리적. 한계: 음성지표→인지/생활 변화 매핑의 임상 타당성 미검증 , STT 기반 실측 미완성(현재 mock)
3	시장성	72	시장 규모·성장성 양호, 진입 시점 적절. 한계: 지불 주체(보호자)의 지불의사·도달 채널 미검증
4	수익모델	60	B2C 구독 + B2B 리포트 2경로 설계됨. 한계: 단위경제(CAC/LTV)·전환율·B2B 도입의사 모두 미검증
5	팀·실행력	68	알고리즘 v2 + MVP 개발 중 + 정부 창업지원 선정 = 실행 신호. 한계: 임상검증·규제·세일즈 역량 보강 필요
6	규제·검증 대응 성숙도	52	비진단 전략 방향은 옳음. 한계(=핵심 리스크): 제품 가치의 토대인 "음성지표 타당성"이 미검증이고, 검증 연구가 아직 설계 단계
—	종합	약 67	문제·시장은 강하고 솔루션 설계도 정교하나, 핵심 가정의 임상 검증과 수익 검증이 미완인 전형적 초기 단계 — 평가자에게는 이 솔직함이 오히려 신뢰 요인

3. 강점

- 1. **단순 안부확인/챗봇이 아닌 차별화된 분석 레이어** — 단발 검사·생존확인이 아니라 개인 기준선 대비 종단 변화 추적(급성 이탈 + 점진 추세 이중 트랙)
- 2. **규제 회피와 의료 연계의 양립** — 비진단 포지셔닝으로 의료기기 규제 부담을 낮추면서, MoCA/MMSE/TMT 매핑 리포트로 의료진 채널 진입 여지 확보
- 3. **MVP 설계의 현실성** — 실제 전화 인프라 없이 통화 시뮬레이션으로 전체 데이터 흐름(등록→일정→통화→구조화→홈/리포트/알림/의료진)을 먼저 검증하는 단계적 접근
- 4. **데이터 자산화 잠재력** — 일상 대화 → 구조화 지표 파이프라인이 축적되면, 후발 진입자가 복제하기 어려운 종단 데이터 해자 형성 가능

4. 리스크

리스크	성격	대응 방향
음성지표의 임상 타당성 미입증	치명적	소규모 코호트 검증 연구 우선 착수(§ 5 가정 1)
비진단 vs 의료기기 경계 모호	규제	식약처/유관 가이드라인 기준 "의료기기 해당 여부" 사전 자문
고령자 음성 수용도 불확실	시장	파일럿에서 응답률·분석가능률 실측
보호자 지불의사 불확실	수익	인터뷰 + 유료 파일럿(pre-sale)
콜드스타트 한계	운영	기준선 미확립(10콜 미만) 구간은 insufficient_data로 명시, 알림 억제 — 데모/온보딩 설계에 반영
개인정보·녹취 민감성	규제/신뢰	동의 모델(녹취·음성·공유·보관) 명시, 보호자+대상자 이중 동의

5. 검증 가정 (가장 중요 — 우선순위순)

이 사업이 "틀릴 수 있는 지점"을 명시한 섹션. 평가·투자 심사에서 가장 신뢰받는 부분.

- 1. **①치명** **음성·언어 지표(X/Y/Z)가 실제 인지/생활 변화를 유의하게 반영한다.**
현재 상태: 가정, 미검증 · 검증 설계: 소규모 고령자 코호트에서 X/Y/Z 점수와 표준 검사(MoCA/MMSE/TMT 등)의 상관·민감도 분석 · 실패 시: 제품 핵심 가치 붕괴 → 그 전까지는 "참고 지표(검증 진행 중)"로만 외부 표현
- 2. **②높음** **고령 사용자가 정기 AI 전화를 수용하고, 분석 가능한 발화를 산출한다.**
검증: 파일럿 통화 응답률·중도이탈률·평균 발화량·분석가능률
- 3. **③높음** **보호자가 이 "변화 관찰" 정보에 실제로 지불한다(WTP).**
검증: 인터뷰(과거 지출 기반) + 유료 파일럿/사전결제
- 4. **④중상** **의료진이 리포트를 진료 참고자료로 채택한다.**
검증: 의원 1~2곳 PoC, 리포트 유용성·사용성 피드백
- 5. **⑤중** **비진단 포지셔닝이 규제와 가치 전달을 동시에 만족한다.**
검증: 규제 자문, 의료기기 해당성 사전 검토
- 6. **⑥중** **채널별 CAC가 LTV 대비 합리적이다.**
검증: 채널(치매안심센터·의원·커뮤니티) 초기 획득 실험